

Sepsis y Shock Séptico

Definición

Sepsis = Infección + Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS) → En la práctica: **infección con compromiso sistémico**.

Diagnóstico

- El diagnóstico es **clínico**. Se piden exámenes en dos direcciones:
- Confirmar el foco infeccioso** (Rx Tórax, Sedimento urinario, Hemocultivos, etc.)
- Cuantificar la respuesta inflamatoria sistémica:**

TABLA 10.1.1: PARÁMETRO VS VALOR DE ALTERACIÓN	
PARÁMETRO	VALOR DE ALTERACIÓN
Leucocitos	> 10.000-11.000/mm³
PCR	> 1 mg/dL (> 10 mg/L)
VHS	> 12-20 mm/hr
Procalcitonina	> 5-10 ng/mL → Alta especificidad para sepsis de causa bacteriana

EUNACOM CRITERIOS

La Procalcitonina (PCT) es el marcador más **específico** de sepsis bacteriana. PCT > 10 es casi diagnóstico de sepsis.

Tratamiento General de la Sepsis

- Suero Fisiológico** → Reposición volémica inmediata (1ª medida).
- Antibióticos** → Empíricos según el foco infeccioso hasta tener cultivos. No retrasarlos.
- Soporte general** → Corrección electrolítica, renal, hepática, etc.
- Desfocar el foco** → Si hay foco quirúrgico (fasciitis necrotizante, osteomielitis grave) → debridamiento o cirugía.

Shock Séptico

Definición: Sepsis que **no responde a ~1.5 L de suero fisiológico**. (O documentado directamente por medición invasiva con baja resistencia vascular periférica.)

- Es un **shock distributivo/vasodilatador** (↓ RVP).
- Tratamiento adicional:** Agregar **Noradrenalina** en bomba de infusión continua (vasopresora de elección).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 65 años con neumonía adquirida en la comunidad presenta fiebre 39°C, taquicardia, PA 60/40 mmHg que no responde a la administración de 1.5 litros de suero fisiológico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

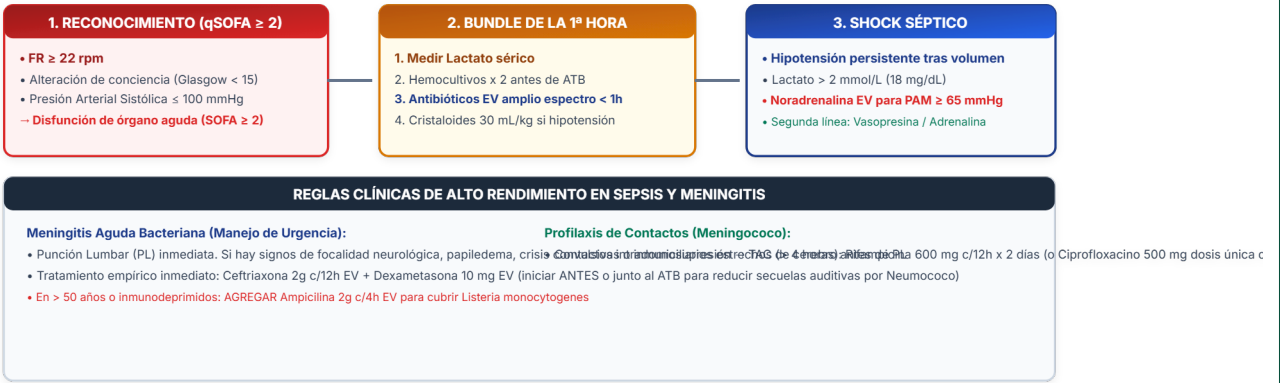
EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Sepsis. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Sepsis = infección + SIRS (síndrome de respuesta inflamatoria sistémica), es decir, infección con compromiso sistémico.
- Parámetros inflamatorios: leucocitos >10.000/mm³, PCR >1 mg/dL (o >10 mg/L), VHS >12-20. Todos inespecíficos.
- Procalcitonina es más específica para sepsis: >10 confirma causa infecciosa, entre 5-10 muy probable.
- Tratamiento: 1° suero fisiológico (reposición de volemia), 2° antibióticos según foco, 3° soporte general.
- Shock séptico: no responde a 1.5 L de suero fisiológico o resistencia vascular periférica disminuida documentada. Agregar noradrenalina.
- En osteomielitis o fascitis necrotizante grave puede ser necesaria la remoción quirúrgica del foco (desfocación).

FIGURA 10.1: ALGORITMO DE SEPSIS-3 Y BUNDLE DE REANIMACIÓN



EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SEPSIS)

PREGUNTA 1

Paciente de 65 años con neumonía adquirida en la comunidad presenta fiebre 39°C, taquicardia, PA 60/40 mmHg que no responde a la administración de 1.5 litros de suero fisiológico. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A)** Administrar más suero fisiológico hasta completar 3 litros
- B)** Iniciar noradrenalina endovenosa
- C)** Solicitar procalcitonina para confirmar sepsis
- D)** Realizar cirugía para remover el foco infeccioso
- E)** Cambiar antibióticos a esquema de mayor espectro

PREGUNTA 2

Paciente hospitalizado por infección urinaria presenta fiebre, taquicardia y leucocitosis de 15.000/mm³. Se solicita procalcitonina que resulta en 12 ng/mL. ¿Cuál es la interpretación más correcta?

- A)** Descarta sepsis, probablemente es una respuesta inflamatoria no infecciosa
- B)** Confirma que el SIRS es de causa infecciosa, compatible con sepsis
- C)** Indica necesidad de iniciar drogas vasoactivas de inmediato
- D)** Es un resultado inespecífico que no ayuda al diagnóstico
- E)** Indica necesidad de remoción quirúrgica del foco

PREGUNTA 3

Respecto al manejo inicial de un paciente con sospecha de sepsis, ¿cuál es la primera medida terapéutica que debe realizarse?

- A)** Iniciar antibióticos empíricos de amplio espectro
- B)** Solicitar hemocultivos y procalcitonina
- C)** Reposición de volemia con suero fisiológico
- D)** Iniciar noradrenalina para mantener presión arterial
- E)** Instalación de catéter de Swan-Ganz para monitorización

RESUMEN: SEPSIS

Esta clase aborda el concepto de sepsis, definida como una infección con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SIRS), es decir, una infección con compromiso sistémico. El diagnóstico es clínico, complementado con exámenes dirigidos al foco infeccioso y parámetros inflamatorios como leucocitos (>10.000-11.000/mm³), PCR (>1 mg/dL o >10 mg/L), VHS (>12-20) y procalcitonina, siendo esta última más específica para sepsis (>10 confirma causa infecciosa, entre 5-10 es muy probable). El tratamiento se basa en tres pilares: primero, reposición de volemia con suero fisiológico como medida número uno; segundo, antibióticos según el tipo de bacteria o el foco infeccioso; y tercero, soporte general incluyendo manejo hidroelectrolítico, renal y hepático. El shock séptico se define como aquel que no responde a un litro y medio de suero fisiológico, o cuando se objetiva resistencia vascular periférica disminuida mediante catéter de Swan-Ganz. En este caso se agrega noradrenalina como droga vasoactiva, dado que es un shock vasodilatador. En casos particulares como osteomielitis o fascitis necrotizante grave, puede ser necesaria la remoción quirúrgica del foco infeccioso.